

F5 인계 요약 보고서 — VP-012

핵심 요약

- 환자: 정우식 (VP-012) — 10회차 (2027-01-14), 총 10세션 · 183일
- 주호소: 건강검진에서 간 수치가 많이 올라가서 술을 줄이려고 노력 중이지만, 스트레스를 받을 때 술 생각이 자주 나고 한 잔 마시면 손 떨림이 줄어들고... (상세 부록 1 참조)
- 위험 플래그: 자살사고 문항 양성 이력 없음 (자가보고 기준)
- 최신 설문: PHQ-9 21/27 (중증) ↓ (22→21, 1회차 대비)
- 주요 우려: 특이 우려 사항 없음

면책 조항

- 자가보고(AI 대화형 문진) 기반 비공식 문서이며 공식 의무기록·의학적 진단이 아닙니다.
- AI 예상질환(하단)은 유사도 기반 참고 정보일 뿐 확률·가능성·진단이 아닙니다.
- 최종 진단과 치료 방향은 반드시 의료진의 판단에 따라 결정되어야 합니다.

위험/안전 평가

당해 세션(10회차, 2027-01-14) 위험평가: 자살/자해 사고 탐색 질문에 부인 — 환자 발화: "전혀 없습니다. 그런 생각은 한 번도 해본 적 없고, 제 문제는 오로지 술을 줄이는 일뿐이에요.". 위기 단계(CTRS) 4/5 — 경도 우려 (준안정).

해당 없음 — item-9 양성/안전 의뢰 이력 없음

최신 시행 척도 안내: 당해 세션에 F3 문진이 시행되어 별도 최신성 안내가 필요하지 않습니다.

주호소 및 현병력

주호소: 건강검진에서 간 수치가 많이 올라가서 술을 줄이려고 노력 중이지만, 스트레스를 받을 때 술 생각이 자주 나고 한 잔 마시면 손 떨림이 줄어들고 마음이 가라앉는 상황

현병력: 건강검진에서 간 수치 상승 결과를 받은 후 술을 줄이려고 노력하여 매일 마시던 것을 주 5일 정도로 줄였으나, 여전히 술 생각이 자주 나고 스트레스 받을 때 특히 강하게 들며, 손이 떨릴 때 한 잔 마시면 증상이 완화되는 현상이 있음

정신상태검사 (MSE)

텍스트 문진 특성상 관찰 기반 MSE는 평가 불가; 대화에서 도출된 소견 없음

전체 세션 요약

이 표의 값은 AI가 진행한 대화형 문진(F1)에서 환자가 자가보고한 내용이며, 임상과의 직접 평가나 검증된 척도 시행이 아닙니다.

슬롯	최신값
주호소	건강검진에서 간 수치가 많이 올라가서 술을 줄이려고 노력 중이지만, 스트레스를 받을 때 술 생각이 자주 나고 한 잔 마시면 손 떨림이 줄어들고... (상세 부록 2 참조)
현병력	건강검진에서 간 수치 상승 결과를 받은 후 술을 줄이려고 노력하여 매일 마시던 것을 주 5일 정도로 줄였으나, 여전히 술 생각이 자주 나고 스트... (상세 부록 3 참조)
정신과 과거력	중학교 때 아버지와 크게 다툰 기억이 가끔 떠올라 술 없이는 감정을 다스리기 힘들 때가 많음
신체질환/신경학적 병력	건강검진에서 간 수치 상승 결과
개인사/사회력	지인 모임에 예전처럼 자주 나가지 못하고 식당 일로 인해 정신없는 날이 많으며, 배우자와는 자주 다투서 혼자 버티는 상황임
가족력	가족 중 특별히 그런 분은 없었으나, 어릴 때 아버지가 술을 자주 드셨고 중학교 때 한 번 크게 다툰 적이 있음
음주·흡연·물질사용	한 병 반도 자주 마시고 있음
위험평가	자살/자해 사고 탐색 질문에 부인 — 환자 발화: "전혀 없습니다. 그런 생각은 한 번도 해본 적 없고, 제 문제는 오로지 술을 줄이는 일뿐이에요... (상세 부록 4 참조)

주요 경과

- 위험평가: S1: '자살/자해 사고 표현 있음 — 환자 발화: "아니요, 그런 적은 없었어요. 정신과를 간 적도 없고, 상담 같...' → S6: '자살/자해 사고 탐색 질문에 부인 — 환자 발화: "아니요, 그런 생각은 전혀 없어요. 그냥 술을 줄이고 싶...' → S10: '자살/자해 사고 탐색 질문에 부인 — 환자 발화: "전혀 없습니다. 그런 생각은 한 번도 해본 적 없고, 제...'

- 주호소: S1: '8-10년 전부터 거의 매일 소주 한 병 이상 마시며, 최근 2-3년 새 양이 늘어나 한 병 반도 마시고,...' → S6: '간 수치가 다시 안 좋아져서 술을 줄이고 싶다는 고민' → S9: '건강검진에서 간 수치가 많이 올라가서 술을 줄이려고 노력 중이지만, 스트레스를 받을 때 술 생각이 자주 나고...'

- 현병력: S1: '15년 전 식당 개업 후 음주 시작, 초기 하루 한두 잔에서 최근 2-3년 사이 한 병 반으로 증가, 손님...' → S5: '식당이 비수기라 경제적으로 빠듯한 상황에서 스트레스가 많을 때 술을 더 많이 마시게 되고, 한 병 반도 자주...' → S8: '건강검진에서 간 수치 상승 결과를 받은 후 술을 줄이려고 노력하여 매일 마시던 것을 주 5일 정도로 줄였으나...'

- 음주·흡연·물질사용: S1: '15년 전부터 매일 소주 한 병 이상, 최근 2-3년 사이 한 병 반으로 증가' → S5: '한 병 반도 자주 마시고 있음'

시행된 설문

AI가 진행한 대화형 문진 결과이며, 검증된 임상 설문 시행이 아닙니다.

PHQ-9 21/27 (중증) — 10회차 (2027-01-14)

응답: 2,2,3,3,2,3,3,3,0

자살사고 문항(9번): 음성 | 문진 방식: natural

종단 추세 — 전체 방향: 개선

전체 방향은 척도·위기단계·정서 방향의 다수결로 계산되며, 악화 신호가 하나라도 있으면 악화로 우선 판정합니다. 정서 포함 여부에 따라 결과가 달라질 수 있습니다.

항목	방향	근거
AUDIT-C 총점	개선	AUDIT-C: 세션 7→8: 11 → 10 (-1)
PHQ-9 총점	개선	PHQ-9: 세션 1→10: 22 → 21 (-1)
위기 단계(CTRS)	개선	세션 1→10: 3 → 4 (+1)
감성 점수	개선	세션 1→10: -0.6 → -0.4125 (+0.188)
문진 항목 총족도	개선	세션 1→10: 5 → 8 (+3)

- 위기 반응 발생 세션 없음
- 위험 고조 세션 중 설문 미시행 사례 없음
- 종단 추세 일관성(설문·CTRS·감성): 일치

추세 차트

VP-012_20260715_171159_temporal_scales_ctrs_sentiment.png

F4 종단 추이 — VP-012 VP-012

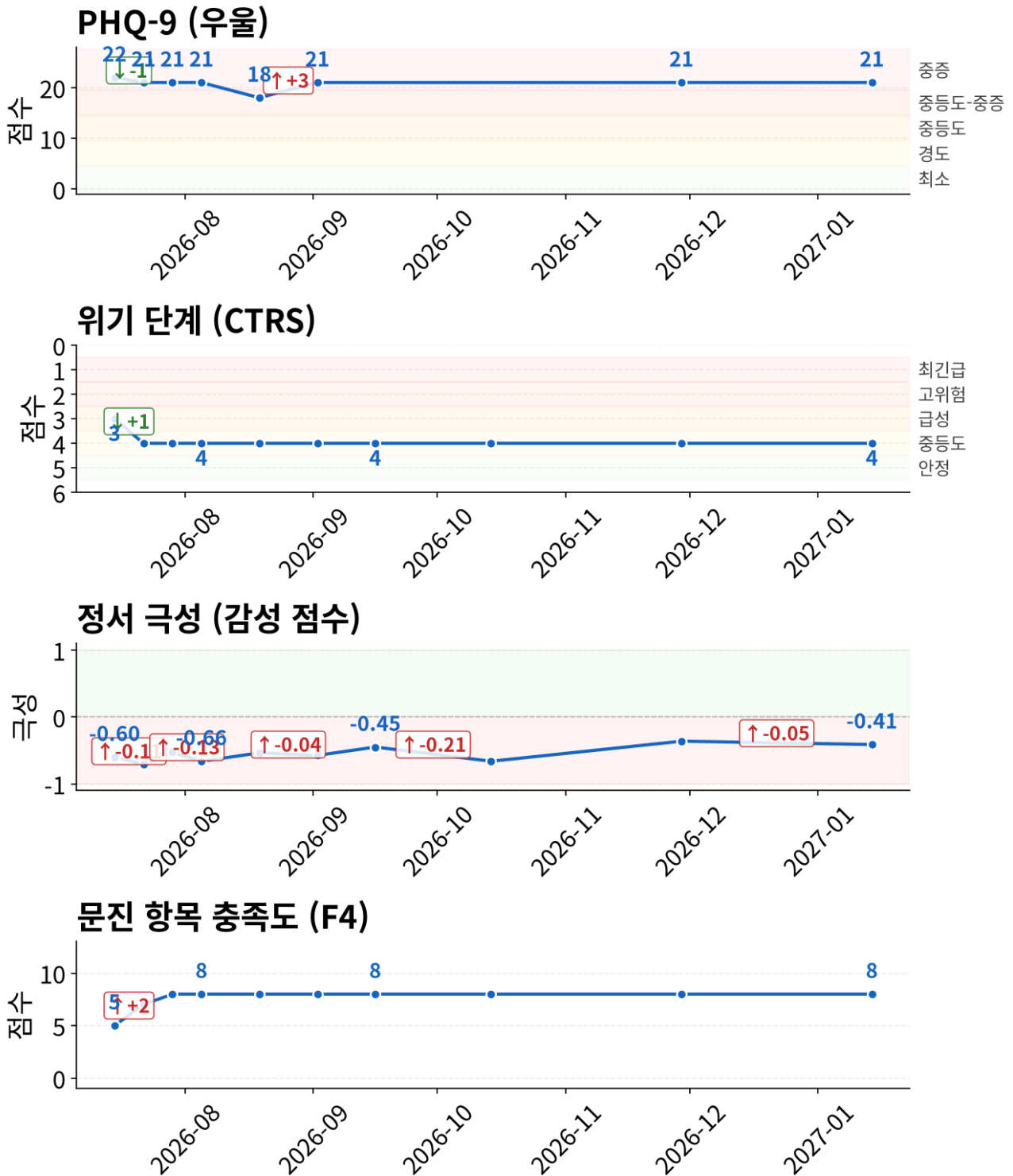


그림 1. 설문 총점·위기 단계(CTRS)·정서·문진 충족도 추이 (10세션, 183일) — 위기 단계는 값이 낮을수록(1에 가까울수록) 위험이 높습니다.

VP-012_20260715_171159_temporal_ctrs_zoom.png

F4 위기단계(CTRS) 확대 — VP-012

VP-012

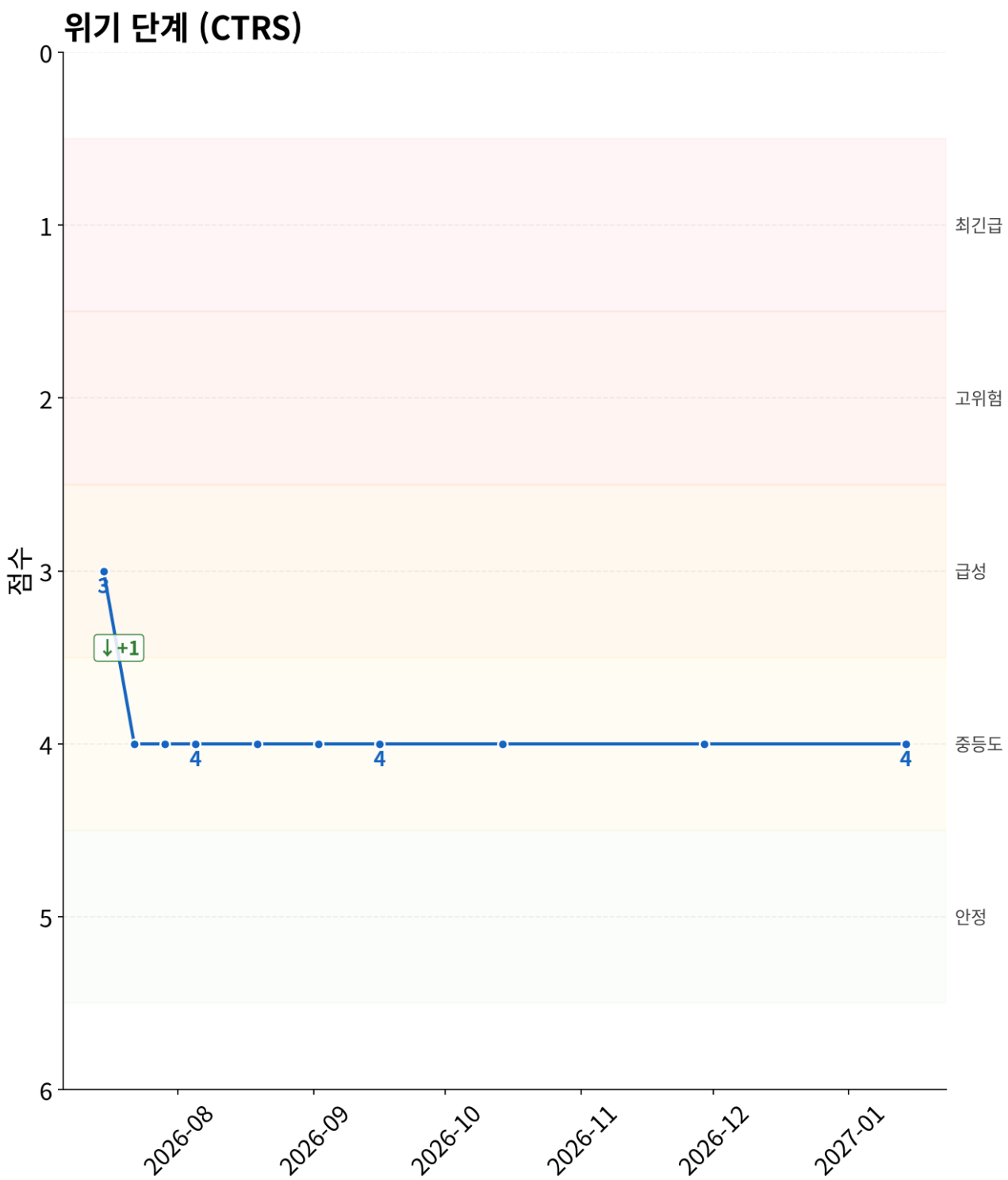
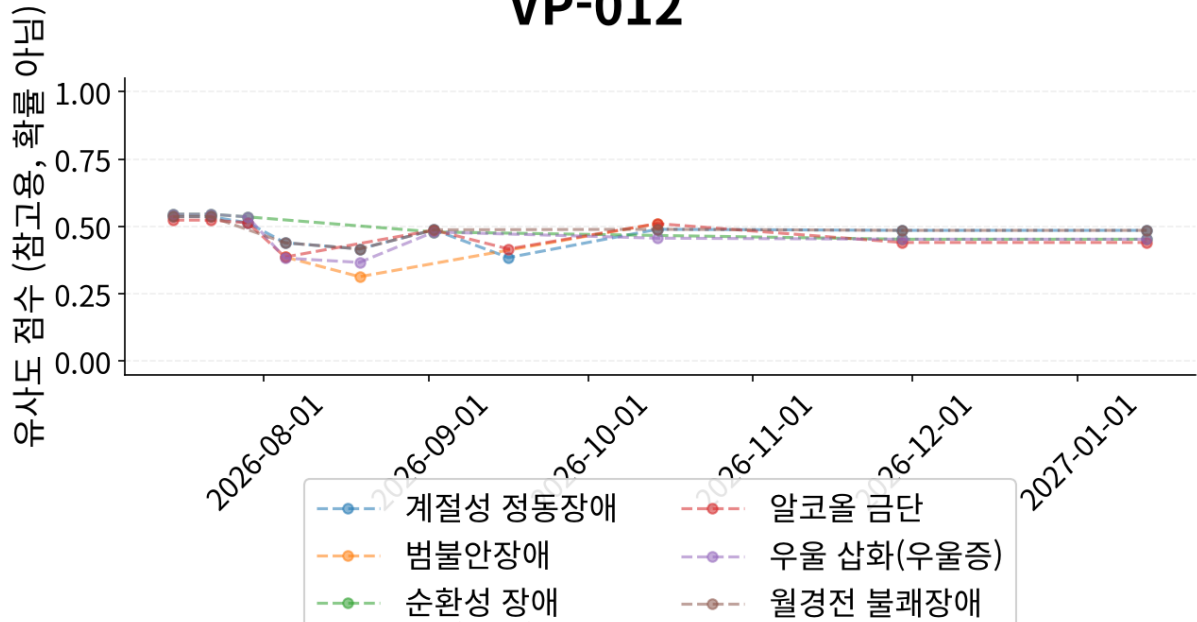


그림 2. 위기 단계(CTRS) 확대 추이 — 1(최긴급)에 가까울수록 위험, 5(안정)에 가까울수록 안정적입니다.

VP-012_20260715_171159_temporal_disease_similarity.png

질환 유사도 추이 (F4, 질환별) VP-012

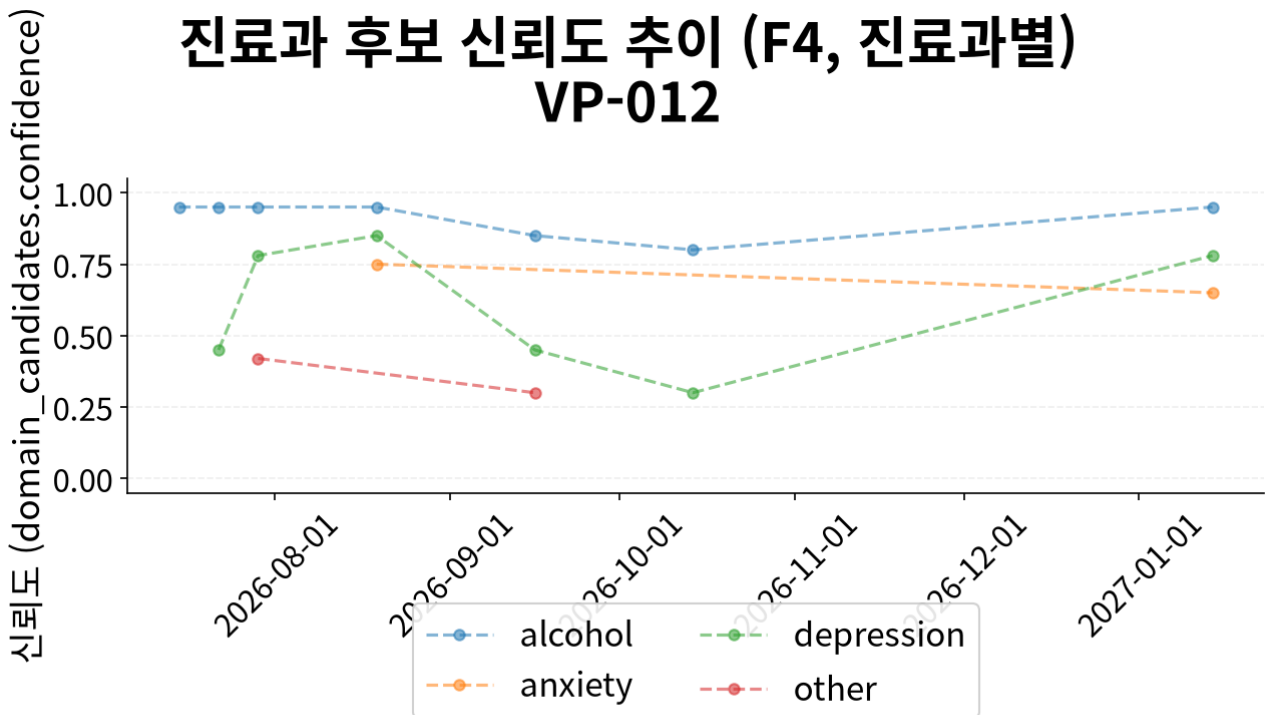


점선·저채도 선 = 낮은 신뢰도 시각 신호. VAL-014(마해결): F2 질환 후보 산출의 타당성이 아직 검증되지 않았습니다 — 이 추이는 노이즈가 포함된 입력을 기반으로 계산되며, 임상적 추이 해석 용도로 사용할 수 없습니다.

그림 3. 세션별 질환 유사도 추이 — 점선·저채도 선은 참고용 유사도 신호일 뿐이며 확률·가능성·진단이 아닙니다.

VP-012_20260715_171159_temporal_domain_confidence.png

진료과 후보 신뢰도 추이 (F4, 진료과별) VP-012



점선·저채도 선 = 낮은 신뢰도 시각 신호.

그림 4. 세션별 진료과 후보 신뢰도 추이 — 값이 높을수록 해당 진료과 매칭 신뢰도가 높습니다.

AI 참고 정보 (비진단)

⚠ 유사도(similarity)일 뿐 확률·가능성·신뢰도가 아닙니다 — 임상 판단 대체 불가.

순위	질환	유사도
공동 1위	계절성 정동장애	0.485
공동 1위	월경전 불쾌장애	0.485
공동 3위	우울 삽화(우울증)	0.452

기타 후보: 순환성 장애(0.452), 알코올 금단(0.440)

disclaimer: 이 정보는 AI가 생성한 참고용 예상 질환 후보이며 의학적 진단이 아닙니다. 함께 제공되는 설문 추천(recommended_questionnaire) 역시 초기 상담(인테이크) 지원을 위한 척도 제안일 뿐, 진단적 판단이 아닙니다. 최종 진단과 치료 방향은 반드시 의료진의 판단에 따라 결정되어야 합니다.

권장 진료과 및 후속 조치

진료과	사유
정신건강의학과	알코올 사용장애와 관련된 금단 증상(손 떨림, 불안), 간 수치 상승, AUDIT/CAGE 스크리닝 양성 가능성, PHQ-9 21점(중증 우울증), GAD-7 양성 가능
내과	간 수치 상승 및 알코올 관련 간 질환 관리 필요

추천 설문: PHQ-9 — PHQ-9 screens depressive-symptom burden only, does not screen manic/hypomanic symptoms — bipolar-spectrum presentations need clinician follow-up regardless of score.

약물 정보: 별도 구조화 항목 없음, HPI/병력 서술 포함 여부만 확인

임상 종합 소견

AI 종합 소견 미생성 (narrative disabled)

상세 부록

1. 주호소 전문

건강검진에서 간 수치가 많이 올라가서 술을 줄이려고 노력 중이지만, 스트레스를 받을 때 술 생각이 자주 나고 한 잔 마시면 손 떨림이 줄어들고 마음이 가라앉는 상황

2. 주호소 최신값 전문

건강검진에서 간 수치가 많이 올라가서 술을 줄이려고 노력 중이지만, 스트레스를 받을 때 술 생각이 자주 나고 한 잔 마시면 손 떨림이 줄어들고 마음이 가라앉는 상황

3. 현병력 최신값 전문

건강검진에서 간 수치 상승 결과를 받은 후 술을 줄이려고 노력하여 매일 마시던 것을 주 5일 정도로 줄였으나, 여전히 술 생각이 자주 나고 스트레스 받을 때 특히 강하게 들며, 손이 떨릴 때 한 잔 마시면 증상이 완화되는 현상이 있음

4. 위험평가 최신값 전문

자살/자해 사고 탐색 질문에 부인 — 환자 발화: "전혀 없습니다. 그런 생각은 한 번도 해본 적 없고, 제 문제는 오로지 술을 줄이는 일뿐이에요."

슬롯별 전체 변화 이력 (미압축)

주호소

S1: '8-10년 전부터 거의 매일 소주 한 병 이상 마시며, 최근 2-3년 새 양이 늘어나 한 병 반도 마시고, 스트레스 받을 때마다 술 생각이 먼저 나며 한 번 마시기 시작하면 멈추기 어려움' → S3: '간 수치가 걱정되어 술을 줄여야겠다고 생각했으나, 식당 일로 인한 스트레스로 다시 술이 조금씩 늘어나고 있음' → S4: '간 수치가 걱정되어 술을 줄이려고 했으나 식당 일로 인한 스트레스로 다시 술이 조금씩 늘어나고 있음' → S5: '식당이 비수기라 경제적으로 빠듯한 날일수록 술을 더 많이 마시게 되고, 한 병 반도 자주 마시며 기분이 더 가라앉는 상황' → S6: '간 수치가 다시 안 좋아져서 술을 줄이고 싶다는 고민' → S7: '간 수치가 다시 나빠져서 술을 줄이고 싶은 고민' → S8: '건강검진에서 간 수치가 많이 올라가서 술을 줄이고 싶지만, 매일 마시던 것을 주 5일 정도로 줄였음에도 술 생각이 자주 나고 스트레스 받을 때 특히 강하게 들며, 손이 떨릴 때 한 잔 마시면 나아지는 증상이 있음' → S9: '건강검진에서 간 수치가 많이 올라가서 술을 줄이려고 노력 중이지만, 스트레스를 받을 때 술 생각이 자주 나고 한 잔 마시면 손 떨림이 줄어들고 마음이 가라앉는 상황'

현병력

S1: '15년 전 식당 개업 후 음주 시작, 초기 하루 한두 잔에서 최근 2-3년 사이 한 병 반으로 증가, 손님 없거나 스트레스 시 음주 충동 심화, 아침 손 떨림 및 피로감 동반, 음주 중단 시 악순환 반복' → S2: '건강검진에서 간 상태가 걱정된다고 언급' → S3: '8-10년 전부터 거의 매일 소주 한 병 이상 마시기 시작, 최근 2-3년 새 한 병 반으로 양이 증가, 스트레스 받을 때마다 술 생각이 먼저 나고 한 번 마시기 시작하면 멈추기 어려움' → S4: '간 수치 문제로 술 줄이려 했으나 식당 일로 인한 스트레스로 술이 다시 늘어나기 시작함. 집사람과 술로 인한 다툼 발생 후 마음이 무거워짐' → S5: '식당이 비수기라 경제적으로 빠듯한 상황에서 스트레스가 많을 때 술을 더 많이 마시게 되고, 한 병 반도 자주 마시며 그로 인해 기분이 더 가라앉는 상황' → S6: '간 수치가 또 안 좋아졌다고 말함' → S7: '간 수치가 다시 나빠져서 술을 줄이고 싶은 고민' → S8: '건강검진에서 간 수치 상승 결과를 받은 후 술을 줄이려고 노력하여 매일 마시던 것을 주 5일 정도로 줄였으나, 여전히 술 생각이 자주 나고 스트레스 받을 때 특히 강하게 들며, 손이 떨릴 때 한 잔 마시면 증상이 완화되는 현상이 있음'

음주·흡연·물질사용

S1: '15년 전부터 매일 소주 한 병 이상, 최근 2-3년 사이 한 병 반으로 증가' → S5: '한 병 반도 자주 마시고 있음'

위험평가

S1: '자살/자해 사고 표현 있음 — 환자 발화: "아니요, 그런 적은 없었어요. 정신과를 간 적도 없고, 상담 같은 것도 처음. 이 앱이 처음이에요."; 구체적 계획/의도 부인 — 환자 발화: "15년 전 식당을 열고 나서부터 술을 마시기 시작했어요. 처음엔 하루 한두 잔이었는데, 시간이 지나면서 점점 양이 늘었어요. 특히 손님이 없거나..."' → S3: '자살/자해 사고 탐색 질문에 부인 — 환자 발화: "아니요, 그런 생각은 전혀 없어요. 그냥 술을 줄이고 싶은 거예요."' → S4: '자살/자해 사고 탐색 질문에 부인 — 환자 발화: "아니요, 그런 생각은 전혀 없습니다. 술을 줄이고 싶은 마음은 있지만, 삶 자체를 포기하고 싶은 마음은 전혀 없어요."' → S5: '자살/자해 사고 탐색 질문에 부인 — 환자 발화: "아니요, 그런 생각은 전혀 없어요. 그냥 술을 줄이고 싶은 마음이 클 뿐이에요."' → S6: '자살/자해 사고 탐색 질문에 부인 — 환자 발화: "아니요, 그런 생각은 전혀 없어요. 그냥 술을 줄이고 싶은 거예요."' → S8: '자살/자해 사고 탐색 질문에 부인 — 환자 발화: "네, 맞아요. 간 수치가 걱정돼서 줄이려고는 했는데, 한 번 마시기 시작하면 멈추기가 어려워요. 의지로 안 되는 것 같아서 답답하기도 하고, 그..."' → S9: '자살/자해 사고 탐색 질문에 부인 — 환자 발화: "네, 스트레스를 받으면 자꾸 술 생각이 나요. 특히 식당 운영하다 보면 아침부터 컨디션이 안 좋을 때가 많은데, 그럴수록 한 잔이라도 마셔야 정..."' → S10: '자살/자해 사고 탐색 질문에 부인 — 환자 발화: "전혀 없습니다. 그런 생각은 한 번도 해본 적 없고, 제

문제는 오로지 술을 줄이는 일뿐이에요."

모델: solar-pro3-260323 · 생성 시각: 2026-07-15T17:31:05.371227 · 세션ID: f1_VP-012_followup

설문 문항 출처: v1, verbatim Pfizer/phqscreeners.com Korean PHQ-9 PDF, retrieved 2026-07-13 (item_bank_v1_sources.md § 1.2/ § 1.3, appendix § A1); translation chosen per ADR-033 decision 1 (Seo & Park 2015's Korean validation study administered this same translation)

시스템 참고 (내부 감사용, 임상 판단 근거 아님)

종단 추세 판정 근거: overall_direction은 세션별 척도/CTRS/sentiment 방향의 다수결(worsened-priority)로

계산되며(src.f4::_overall_direction), sentiment 포함 여부에 따라 verdict가 달라질 수 있습니다(REV-045 row 2) — 세부 근거는 trend_verdicts의 evidence를 참고하십시오.